



PROTOCOLO DE MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO EN EL PACIENTE CRÍTICO

UCI



1. DEFINICIÓN



Ausencia de deposiciones ≥ 3 días consecutivos en paciente crítico con aporte enteral.



Incidencia UCI:
3–84% (hasta 75,8%)

NPT / SUEROTERAPIA



Definición operativa: la ausencia de deposición en los primeros 3–5 días puede ser fisiológica. Valorar estreñimiento/hipomotilidad si > 5 días sin deposición o antes si hay distensión, dolor, aumento de PIA o intolerancia al soporte nutricional.



LO QUE SÍ HACER

Vigilar distensión, dolor, PIA y factores de riesgo. Considerar profilaxis. Descartar íleo u obstrucción.



LO QUE NO HACER

No aplicar rígidamente la regla de 3 días en NPT/ayuno. No usar laxantes potentes si está asintomático. No confundir con íleo o pseudoobstrucción.

2. VALORACIÓN

A) Factores de riesgo



Ventilación mecánica



Inmovilidad



Ayuno



Sepsis



Fármacos: opiáceos, sedantes, anticolinérgicos

B) Medidas generales



Hidratación (250 mL/d de agua por SNG/oral)



Movilidad precoz



Correcciones iónicas: K, Mg, Ca



NE precoz



Fibra insoluble (aumenta volumen de heces)



Fibra soluble (ablanda heces)



Combinar ambos tipos de fibra + agua + laxante osmótico

C) SIGNOS DE ALARMA



RHA negativos



Distensión abdominal



Aumento de PIA > 20 mmHg



Dolor abdominal



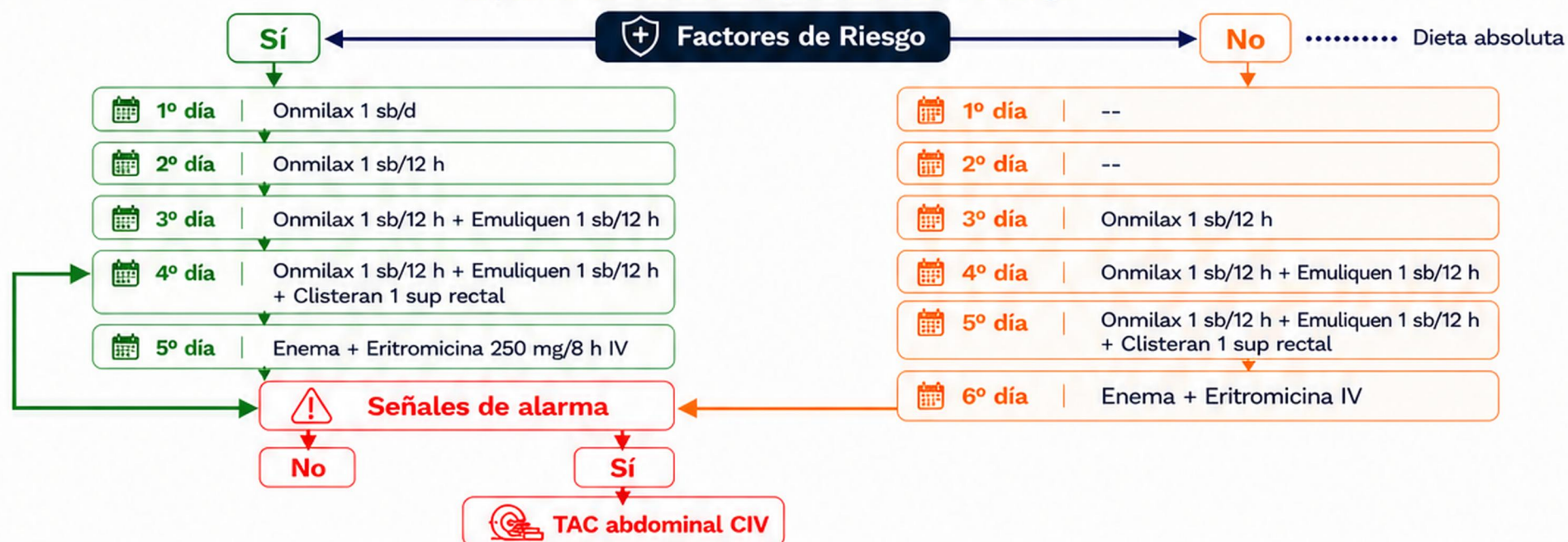
Alteraciones analíticas:

$\uparrow$ PCR $\uparrow$ PCT $\uparrow$ leucocitos $\uparrow$ láctico $\uparrow$ LDH

Señales de alarma $\rightarrow$ TAC abdominal con CIV

3. ALGORITMO DE MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO EN UCI

Esquema de decisión según factores de riesgo



4. INSTRUCCIONES DE MANEJO



• Cómo retroceder: si objetivo alcanzado, volver al escalón previo



• Si no respuesta, reevaluar fecaloma, íleo o pseudoobstrucción



• Documentar diariamente

6. MANEJO DEL ÍLEO SEVERO (NEOSTIGMINA)



• Bolo: 2 mg IV lento (3–5 min)



• Perfusión continua: 5 mg/50 cc, iniciar a 4 mL/h; subir a 8 mL/h si no eficaz



• Seguridad: ECG continuo + atropina 0,5–1 mg preparada

6. ESQUEMA GENERAL



a. Iniciar profilaxis laxante desde el ingreso en pacientes con riesgo.

b. Si no hay deposición en 48 h, intensificar el régimen.

c. A las 72 h, evaluar impactación, descartar obstrucción y escalar tratamiento.



OBJETIVO: prevenir y tratar precozmente el estreñimiento en UCI



EVALUAR DIARIAMENTE Y DOCUMENTAR